救急外来診察室における診療支援

～救急外来常駐の検査技師として～

◎東 さくら[1)]、伊藤 英史[1)]、磯部 勇太[1)]、宮本 康平[1)]、西尾 祐貴[1)]、大嶋 剛史[1)]
医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院[1)]

【はじめに】
救急外来では、重症患者や救急搬送患者への対応に人的資源が集中するため、ウォークイン（診察室）患者への迅速な介入が困難となる場合がある。院内トリアージを実施しているものの、診察や検査の過程で早期介入の必要性が判明する症例も存在する。このため、ウォークイン患者に対しても適時適切な医療提供が求められている。当院では臨床検査技師が救急外来に常駐し、診察室における診療支援を行っていることから、その業務内容および取り組みについて報告する。

【業務内容】
検査前準備、電解質輸液のルート作成および静脈路確保、採血、POCT（血液ガス・血糖測定）、各種検体採取、心電図検査、検査案内などの診療支援業務を実施している。さらに、検査結果の確認および報告を行うとともに、採取容器、必要検体量、残検体による追加検査の可否など、検査に関する問い合わせ対応も行っている。

【取り組み】
診察室における診療支援として、初療室業務と並行し診察室側の繁忙時には、看護師と連携しながら、前述した検査関連業務を中心とした一連の診療業務を主体的に実施している。検査結果は救急外来に設置した検査システムにより確認し、特に血液ガス分析については電解質異常や代謝異常の早期把握が可能であることから、異常値を認めた際には速やかに臨床医へ報告している。これらの取り組みにより検査および結果報告の迅速化が図られ、診療早期に重症度の再評価が可能となり、結果として優先順位の見直しおよび早期治療介入につながった症例が認められた。

【まとめ】
救急外来に臨床検査技師が常駐し、看護師とともに診察室における診療業務に関与することで、ウォークイン患者への対応の迅速化が図られた。本取り組みは救急外来における診療の質向上に加え、タスクシフト・シェアの推進および人的資源の有効活用につながる可能性が示唆された。

連絡先：0566-25-2948